ICS 11.020
C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.19—2009

针灸技术操作规范
第19部分：腕踝针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—
Part 19：Wrist-ankle acupuncture

2009-02-06 发布　　2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为21个部分：

——第1部分：艾灸；

——第2部分：头针；

——第3部分：耳针；

——第4部分：三棱针；

——第5部分：拔罐；

——第6部分：穴位注射；

——第7部分：皮肤针；

——第8部分：皮内针；

——第9部分：穴位敷贴；

——第10部分：穴位埋线；

——第11部分：电针；

——第12部分：火针；

——第13部分：芒针；

——第14部分：锓针；

——第15部分：眼针；

——第16部分：腹针；

——第17部分：鼻针；

——第18部分：口唇针；

——第19部分：腕踝针；

——第20部分：毫针基本刺法；

——第21部分：毫针针刺手法。

本部分为GB/T 21709的第19部分。

本部分的附录A为规范性附录，附录B、附录C为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分起草单位：天津中医药大学。

本部分主要起草人：郭义、史丽萍、陈泽林、李桂兰、赵雪。

本部分参加起草人：王红、温景荣、孙阁、魏连海、高旸、付均如、郭永明、吴丽萍、裴莹、康婧青、刘阳阳。

引　言

一般标准中所涉及的长度、宽度的计量都要求采用国际单位制，但是人体高矮胖瘦的差异很大，无法采用绝对的标准值描述针灸腧穴部位，只有通过等分折量的方法——骨度折量法描述腧穴部位，才能适用于所有人群和所有个体。1987 年世界卫生组织在韩国汉城召开的国际会议上确定采用“寸”作为针灸经穴标准计量单位。因此，本标准的腧穴定位采用这种计量单位。

针灸技术操作规范
第19部分:腕踝针

1 范围

GB/T 21709的本部分规定了腕踝针的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项及禁忌。

本部分适用于腕踝针技术操作。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于GB/T 21709的本部分。

2.1

腕踝针 wrist-ankle acupuncture

腕踝针针法的简称。在腕踝部选取特定的进针点,用毫针循肢体纵轴沿真皮下刺入一定长度以治疗疾病的方法。

2.2

腕踝针身体分区 the body regions of wrist-ankle acupuncture

腕踝针各进针点治疗范围所构成的6个身体纵行带状区域,分为上下两段。见附录A的第A.1章。

2.3

腕踝针进针点 the needling points of wrist-ankle acupuncture

腕踝针进针的特定部位,在腕部和踝部各有6对,分别对应身体上下6个分区且与各区编号一致。见附录A的第A.2章。

3 操作步骤与要求

3.1 施术前准备

3.1.1 针具选择

根据病情和进针点选择长25 mm或40 mm毫针。

3.1.2 进针点选择

参见附录B。

3.1.3 体位选择

根据病情选择患者舒适、医者便于操作的施术体位。

3.1.4 环境要求

应注意环境清洁卫生,避免污染。

3.1.5 消毒

3.1.5.1 针具消毒:应选择高压蒸汽灭菌法。宜选择一次性毫针。

3.1.5.2 部位消毒:可用75%乙醇或0.2%安尔碘或碘伏在施术部位消毒。

3.1.5.3 医者消毒:医者双手应用肥皂水清洗干净,再用75%乙醇擦拭。

3.2 施术方法

医者一手固定进针部位,另一手拇、食、中指持针,针身与皮肤呈15°~30°角快速刺入真皮下,然后压平针身,使针身循肢体纵轴沿真皮下缓慢刺入,以针下松软、无针感为宜。刺入长度以露出针身2 mm

为宜。不提插捻转。针刺方向一般朝向近心端。病变部位位于四肢末端时针刺方向朝向远心端，此时进针点位置可沿纵轴向近心端移动，以不妨碍腕踝关节活动为宜。出针时一手用无菌干棉球轻压进针点，另一手将针拔出。留针时间和治疗间隔时间参见附录C。

4 注意事项

4.1 针刺部位应防止感染。

4.2 针刺时如出现针感，应将针退至真皮下重新刺入。

4.3 留针期间可用医用胶布固定针柄。

4.4 注意晕针的发生。

4.5 孕妇慎用。

4.6 精神病患者不宜长时间留针。

5 禁忌

5.1 腕踝部位肌肉挛急者。

5.2 针刺部位有血管怒张、瘢痕、伤口、严重溃疡及肿物者。

附　录　A
（规范性附录）
腕踝针身体分区、腕踝针进针点

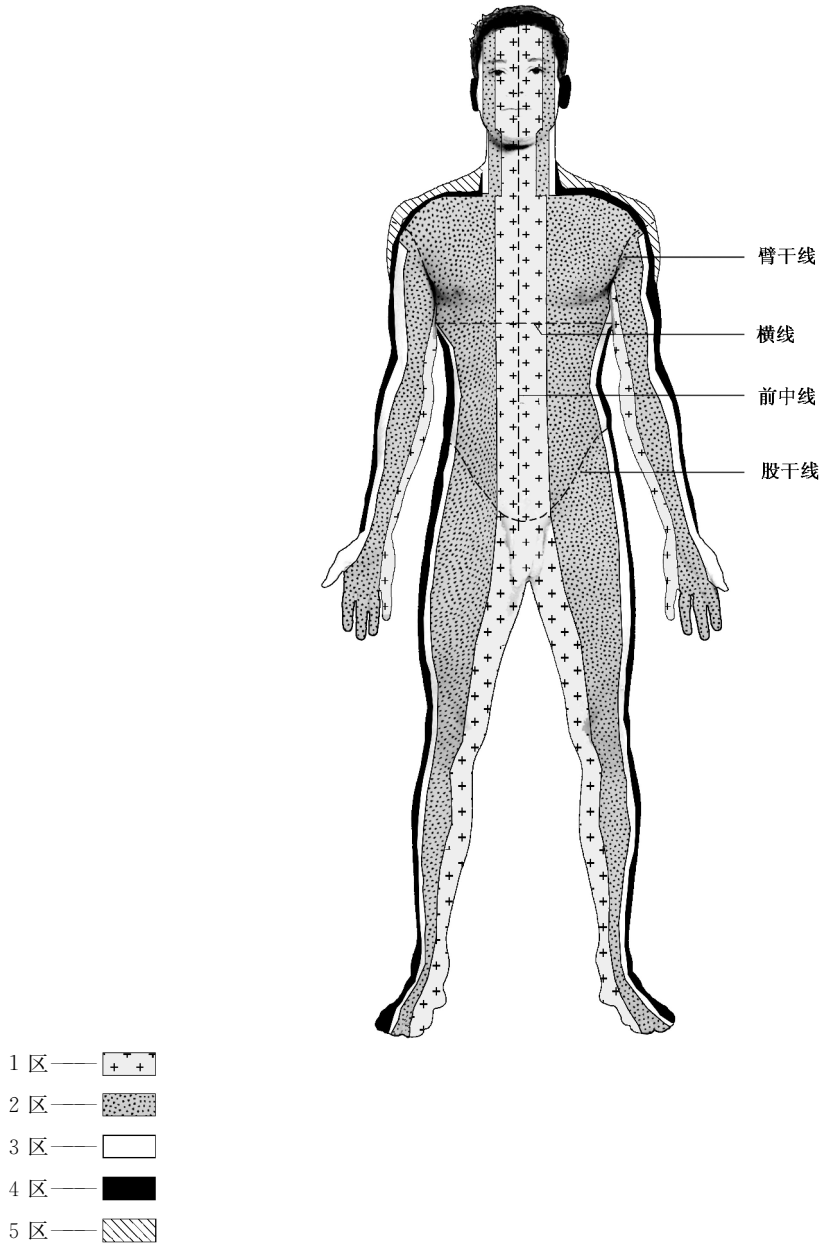
A.1　腕踝针身体分区

身体分区分为纵行六区和上下两段。纵行六区包括头、颈、躯干六区和肢体六区两部分。

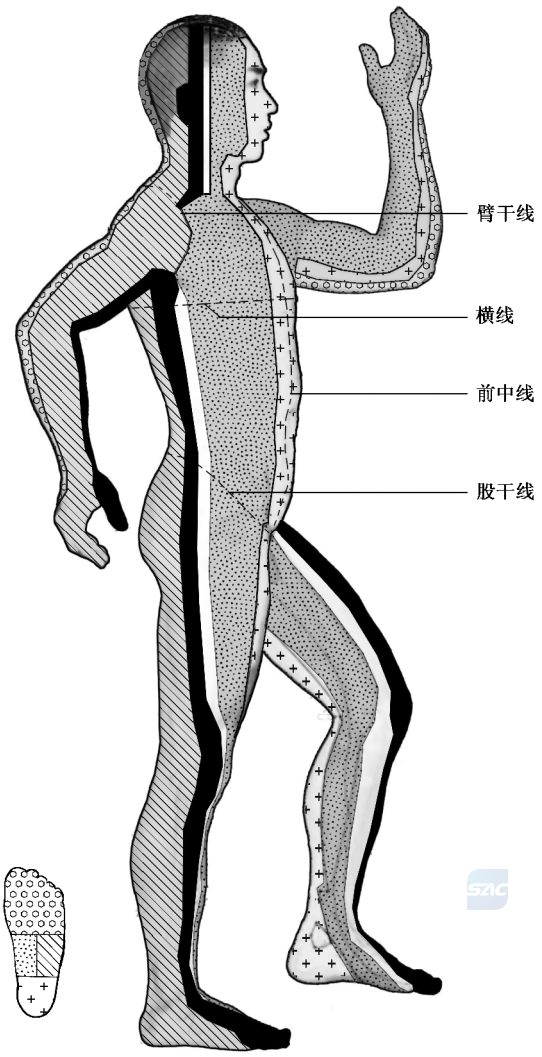
A.1.1　纵行六区

A.1.1.1　头、颈和躯干六区

以前后正中线为标线，将身体两侧面由前向后划分为6个纵行区。用数字1～6编号。见图A.1～图A.3。



图A.1　腕踝针身体分区（正面）



1 区——
2 区——
3 区——
4 区——
5 区——
6 区——

图 A.2　腕踝针身体分区(侧面)

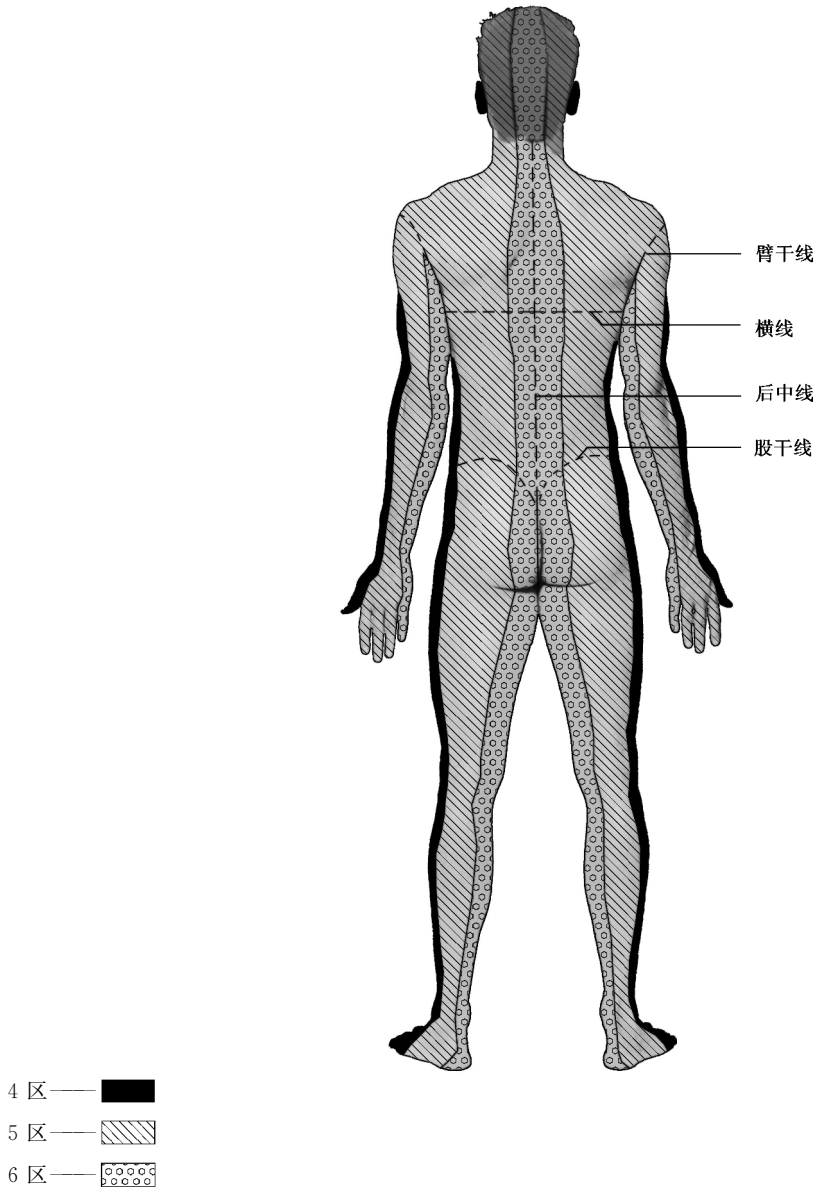


图 A.3　腕踝针身体分区(背面)

1 区:前中线两侧。分别称之为左 1 区、右 1 区。临床常把左 1 区与右 1 区合称为 1 区,以下各区亦同。头面部在前中线至以眼眶外缘为垂直线之间的区域,包括前额、眼、鼻、唇、前牙、舌、咽喉、扁桃体、颏;颈部沿气管、食管;胸部自前中线至胸骨缘,包括胸肋关节、气管、食管、乳房近胸骨缘、心前区(左侧);腹部自前中线至腹直肌区域,包括胃、胆囊、脐部、下腹之膀胱、子宫、会阴部。

2 区:从 1 区边线到腋前线之间所形成的区域,左右对称。头颈部包括颞前部、面颊、后牙、颌下、甲状腺;胸部沿锁骨中线向下区域,包括锁骨上窝、上胸部、乳中部、前胸、肺、肝(右侧)、侧腹部。

3 区:从腋前线至腋中线之间所形成的区域,左右对称。包括沿耳廓前缘、腮腺、腋前缘垂直向下的狭窄区域、乳房近腋前缘部分。

4 区:前后面交界。即腋中线至腋后线之间所形成的区域,左右对称。包括自头顶经耳向下至颈,肩部沿斜方肌缘,胸腹部自腋窝至髂前上嵴的胸侧壁及腹侧部区域。

5 区:腋后线至 6 区边线之间所形成的区域,左右对称。与前面的 2 区相对。包括颞后部、颈后外侧靠斜方肌缘、肩胛冈上窝及肩胛中线垂直向下区域的背和腰。

6 区:后中线两侧,与 1 区相对。包括枕、颈后部、颈椎棘突至斜方肌缘、胸椎棘突至肩胛骨内缘、腰椎与骶正中嵴至尾骨两侧、肛门。

A.1.1.2 肢体六区

以臂干线和股干线分别为躯干与四肢的分界线。臂干线环绕肩部三角肌附着缘至腋窝;股干线自腹股沟至髂嵴。

当两侧的上下肢处于内侧面向前的外旋位置,即四肢的阴阳面和躯干的阴阳面处在同一方向并互相靠拢时,以靠拢处出现的缘为分界,在前面的相当于前中线,在后面的相当于后中线,这样四肢的分区就可按躯干的分区类推。

A.1.2 上下两段

以胸骨末端和两侧肋弓的交接处为中心,划一条环绕身体的水平线称横膈线。横膈线将身体两侧的六个区分成上下两段。横膈线以上各区分别叫做上1区、上2区、上3区、上4区、上5区、上6区;横膈线以下的各区叫下1区、下2区、下3区、下4区、下5区、下6区。如需标明症状在左侧还是右侧,在上还是在下,又可记作右上2区或左下2区等。

A.2 腕踝针进针点

A.2.1 腕部进针点

左右两侧共6对,在腕横纹上2寸(同身寸,相当于内关穴或外关穴)位置上,环前臂做一水平线,从前臂内侧尺骨缘开始,沿前臂内侧中央,前臂内侧桡骨缘,前臂外侧桡骨缘,前臂外侧中央,前臂外侧尺骨缘顺序,依次取上1、上2、上3、上4、上5、上6进针点。见图A.4。

上1:在小指侧的尺骨缘与尺侧腕屈肌腱之间。

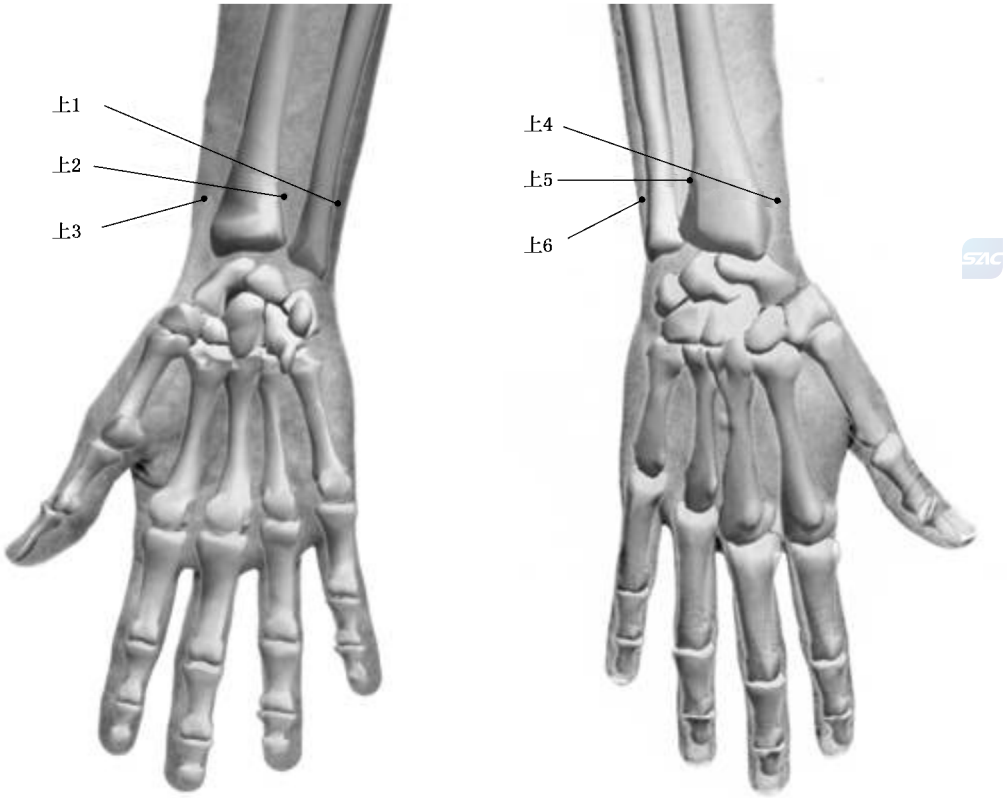
上2:在腕掌侧面的中央,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。相当于内关穴处。

上3:在桡骨缘与桡动脉之间。

上4:在拇指侧的桡骨内外缘之间。

上5:在腕背的中央,桡骨与尺骨两边缘之间。

上6:在腕背侧,距小指侧尺骨缘1分处(同身寸)。



图A.4 腕部进针点位置

A.2.2 踝部进针点

左右两侧共 6 对，在内踝高点上三寸或外踝上三寸（同身寸，相当于三阴交穴或悬钟穴）位置上，环小腿做一水平线，从小腿内侧跟腱缘开始，沿小腿内侧中央，小腿内侧胫骨缘，小腿外侧腓骨缘，小腿外侧中央，小腿外侧跟腱缘顺序，依次取下 1、下 2、下 3、下 4、下 5、下 6 进针点。见图 A.5。

下 1：靠跟腱内缘。

下 2：在踝部内侧面中央，靠内侧胫骨后缘。

下 3：在胫骨前嵴向内 1 分（同身寸）处。

下 4：在胫骨前嵴与腓骨前缘之间的胫骨前肌中点。

下 5：在踝部外侧面中央，靠腓骨后缘。

下 6：靠跟腱外缘处。

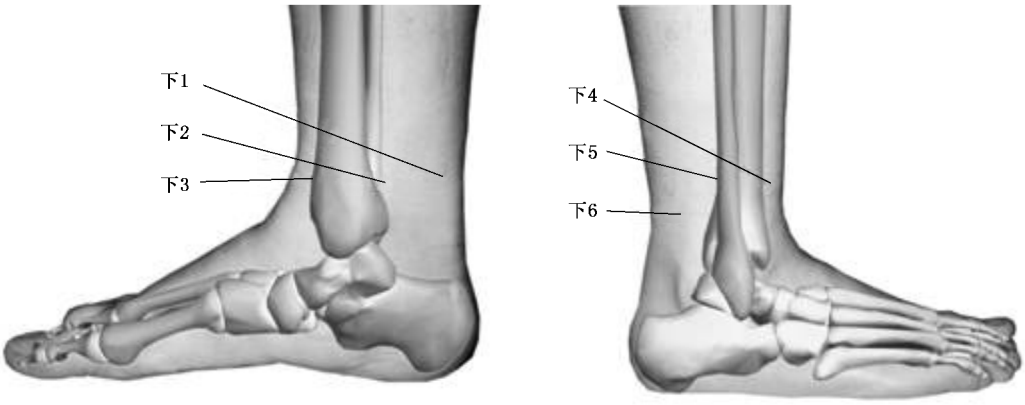


图 A.5 踝部进针点位置

附　录　B
（资料性附录）
进针点选择方法

B.1　根据病位选择进针点

B.1.1　上病选上，下病选下，上下同选。根据疾病的症状和体征所在的上下两段不同的身体分区，选编号相同的腕部进针点或踝部进针点。病变部位位于横膈线附近时，则上下同选。

B.1.2　左病选左，右病选右，左右同选。以前后中线为界，选病变所在同侧的进针点；如症状和体征位于中线附近，则两侧同选。

B.1.3　病位不明，选双上1。不能定位的症状或全身性病症，选两侧上1进针点。

B.1.4　肢体有感觉或运动障碍，发生在上肢者选上5进针点，发生在下肢者选下4进针点。

B.2　根据病症选择进针点

B.2.1　下列病症可选上1：前额痛；面神经麻痹；面肌痉挛；三叉神经痛；眼睑瞤动；近视眼；白内障；麦粒肿；结膜炎；鼻炎；花粉症；前牙痛；耳鸣；冠心病；心律失常；胸痛；植物神经功能失调；失眠；嗜睡；烦躁；梅核气；肢体麻木；荨麻疹；遗尿；甲状腺功能亢进症；抽动秽语综合征；呃逆；高血压病；肠易激惹综合征等。

B.2.2　下列病症可选上2：颞前痛；三叉神经痛；后牙痛；麦粒肿；白内障；面肌痉挛；颞颌关节综合征；甲状腺疾病；胸痛；胁痛；乳腺炎；冠心病；心律失常；美尼尔氏病；手指疼痛、麻木等。

B.2.3　下列病症可选上3：偏头痛；耳前痛；腮腺肿痛；肩周炎；面神经麻痹；颞颌关节综合征；颈肩综合征；胁痛等。

B.2.4　下列病症可选上4：巅顶痛；美尼尔氏病；耳痛；耳鸣；三叉神经痛；面神经麻痹；面肌痉挛；颞颌关节综合征；颈椎病；上肢运动性损伤；颈肩综合征；肩关节前侧痛；中风偏瘫等。

B.2.5　下列病症可选上5：头痛；枕神经痛；眩晕；美尼尔氏病；颈椎病；落枕；颈肩综合征；肩背肌筋膜炎；肩关节痛；中风偏瘫；小儿舞蹈症；帕金森病等。

B.2.6　下列病症可选上6：后头痛；落枕；颈椎病；肩关节后侧痛；上肢运动性损伤；三叉神经痛；颈痛；胸椎小关节紊乱；甲状腺疾病等。

B.2.7　下列病症可选下1：胃痛；脐周痛；下腹痛；遗尿；尿潴留；带下异常；痛经；宫颈糜烂；睾丸炎；腰椎骨质增生；肥胖；植物神经功能失调；腓肠肌痉挛；足跟痛等。

B.2.8　下列病症可选下2：肝区痛；侧腹痛；肠易激惹综合征；阑尾炎；带下异常；痛经；腿内侧痛；内踝关节痛等。

B.2.9　下列病症可选下3：胁痛；髋关节屈伸不利；膝关节痛；踝关节痛等。

B.2.10　下列病症可选下4：侧腰痛；膝关节痛；股外侧皮神经炎；下肢感觉及运动障碍；坐骨神经痛；足背痛等。

B.2.11　下列病症可选下5：腰背痛；腰椎间盘突出症；第三腰椎横突综合征；腰椎骨质增生；坐骨神经痛；股外侧皮神经炎；腿外侧痛；外踝关节痛等。

B.2.12　下列病症可选下6：腰椎间盘突出症；腰椎骨质增生；腰肌劳损；坐骨神经痛；痔痛；便秘；腓肠肌痉挛；足前掌痛等。

附　录　C
（资料性附录）
留针时间、治疗间隔时间

可留针 20 min～30 min。可依病情延长留针时间，但不宜超过 48 h。留针期间不行针。治疗间隔时间可选择每日 1 次或隔日 1 次。